

Praca ze wstydem

Wstyd to **rdzeń** NPD — pod każdą grandiozją (Kernberg, Ronningstam). CFT Gilberta najskuteczniejszy: trening systemu uspokajania. Metaanaliza: $d \approx 0,7-1,0$.

CZAS: 15 min **Wersja edukacyjna** **ŹRÓDŁO:** Gilbert (2009, 2010); Morrison (1989); Kannan & Levitt (2013)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz trzy systemy emocjonalne Gilberta (sekcja 01) — dlaczego restrukturyzacja poznawcza *nie sięga* wstydu. **2** · Zobaczysz, jak rozpoznać wstyd, gdy pacjent mówi „jestem wściekły” (sekcja 02). **3** · Wypełnisz dziennik wstydu — krok 1 pracy CFT (sekcja 03). **4** · Poznasz *strach przed życzliwością* jako pierwszą barierę terapii (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wstyd jest **rdzeniem** doświadczenia NPD — pod każdą grandiozją, manipulacją i agresją kryje się przekonanie „jestem fundamentalnie wadliwy/-a” (Morrison 1989, *Shame: The Underside of Narcissism*). Grandiozja jest *obroną* przed wstydem, *nie* jego brakiem — pacjent z NPD jest **najbardziej** zawstydzony w pokoju, ale nie umie tego okazać. Ronningstam (2011) opisała wstyd jako centralną, ukrytą emocję w NPD. *Terapia poznawczo-behawioralna standardowa* identyfikuje „myśli automatyczne wstydu” i je restrukturyzuje — pacjent intelektualnie zgadza się, ale **nadal czuje wstyd**. Powód: wstyd to przede wszystkim doświadczenie *somatyczne* (ścisk w żołądku, ciepło na twarzy, pragnienie zniknięcia) — restrukturyzacja poznawcza go nie sięga. Terapia skoncentrowana na współczuciu (ang. *Compassion-Focused Therapy*, CFT, Gilbert 2010) celuje wprost we wstyd, trenując *system uspokajania*. Trzy systemy emocjonalne (Gilbert): (1) **system zagrożenia** — kortyzol, układ współczulny; (2) **system dążenia** — dopamina; (3) **system uspokojenia** — oksytocyna, nerw błędny. NPD ma *rozregulowany* system uspokajania — nie umie się uspokoić wewnętrznie, regulacja musi przyjść z zewnątrz (supply). CFT trenuje aktywację tego systemu przez *soothing rhythm breathing, compassionate self imagery, compassionate letter writing*. Kannan & Levitt (2013) w metaanalizie wykazali skuteczność CFT w zaburzeniach wstyd-zależnych z wielkością efektu $d \approx 0,7-1,0$. *Konsekwencja kliniczna*: CFT w NPD wymaga **powolnej introdukcji** — zbyt wczesne ćwiczenia współczucia budzą *strach przed życzliwością* (ang. *fear of compassion*, Gilbert). Pierwsze 8-12 sesji to praca z tym strachem, dopiero potem trening.

01 Trzy systemy emocjonalne — model Gilberta

1 · ZAGROŻENIE

kortyzol, sympatyczny

„Atak, ucieczka, zamarcie”. Aktywny przy wstydzie, krytyce, porażce. W NPD *chronicznie nadaktywny*.

2 · DĄŻENIE

dopamina, nagroda

„Pragnienie, motywacja, sukces”. W NPD *nadużywany* — zastępuje system uspokajania. Pogoń za supply.

3 · USPOKOJENIE

oksytocyna, n. błędny

„Bezpieczeństwo, więź, kojenie”. W NPD *rozregulowany*. **Cel CFT:** nauczyć się aktywować ten system.

Mechanizm w NPD: system uspokajania nie działa wewnętrznie, więc pacjent *wszystko* robi przez system dążenia (osiągnięcia, podziw, kontrola) lub zagrożenia (atak na krytyka, wycofanie). Brak trzeciej drogi — drogi **kojenia siebie samego**. CFT trenuje tę trzecią drogę.

02 © Wstyd ukryty pod złością — jak rozpoznać

Pacjent z NPD *rzadko* mówi „wstydzę się”. Mówi: „**jestem wściekły/-a**”, „to oni są bezczelni”, „nikt mnie tu nie docenia”. Wstyd jest pod złością — ale obu się nie widzi razem.

CO MÓWI PACJENT

„Jestem wściekły/-a.” „Nie zniosę go/jej.” „To była obraza.” „Wykorzystali mnie.” „Świat jest niesprawiedliwy.”

CO JEST POD SPODEM

„Czuję się bezwartościowy/-a.” „Boję się, że zobaczyli, że nie jestem dość dobry/-a.” „Zostałem/-am obnażony/-a.”

PYTANIE ODKRYWAJĄCE

„Pod tą złością — co jeszcze tam jest?” Albo: „Czy gdyby zniknęła złość, co byś poczuł/-a?” Daje pacjentowi przestrzeń bez frontalnej konfrontacji.

SYGNAŁY W CIELE

Ciepło na twarzy, ścisk w żołądku, pragnienie „zniknięcia” wzrokiem. Pochylenie głowy, unikanie kontaktu wzrokowego. Wstyd jest *w ciele*, zanim trafi do słów.

03 ✎ Dziennik wstydu — krok 1 pracy CFT

Wypełnij *tygodniowo*. Cel **nie** jest „nie wstydzić się” — tylko **nazwać, znormalizować, tolerować**. To pierwszy krok ku temu, by wstyd przestał napędzać obronną grandiozę.

SYTUACJA	PIERWSZA REAKCJA złość, obrona, atak	POD ZŁOŚCIĄ — WSTYD?	CO BYM POWIEDZIAŁ/-A BLISKIEMU W TEJ SYTUACJI?	PRÓBA TEGO SAMEGO DLA SIEBIE

04 💡 Strach przed życzliwością — pierwsza bariera

CO CZUJE PACJENT

„Życzliwość wobec siebie to **słabość**.” „Ja muszę być twardy/-a.” „Współczucie to dla loserów.” „Jeśli sobie odpuszczę — to się rozpadnę.”

CO NAPRAWDĘ SIĘ DZIEJE

Życzliwość aktywuje system uspokajania (oksytocyna) — który był nieaktywny. To *nowe* doświadczenie. Mózg interpretuje jako zagrożenie i odrzuca. Trzeba czasu, by się oswoił.

Klucz: wstyd to *radioaktywna* emocja narcyzmu — ukryta, ale promieniująca na wszystko. Restrukturyzacja poznawcza („nie jesteś wadliwy”) **nie wystarcza** — bo wstyd to doświadczenie somatyczne, nie poznawcze. CFT (Gilbert 2010, d ≈ 0,7–1,0 w metaanalizie Kannana & Levitta 2013) trenuje *system uspokajania* przez ćwiczenia kojącego oddechu (*soothing rhythm breathing*), współczującej wyobraźni i pisania listów do siebie z perspektywy mądrego, ciepłego mentora. **Wstyd nie znika przez logikę — zmniejsza się przez bezpośrednie doświadczenie życzliwości wobec siebie.** Wymaga czasu — pierwsze 8–12 sesji to praca z *strachem przed życzliwością*, dopiero potem właściwy trening.